SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0803459-24.2024.8.15.0751
AUTOR: IRENILDA PADILHA DOS SANTOS
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Visto etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Irenilda Padilha dos Santos em face da Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico. O objeto do pedido é o fornecimento contínuo do medicamento *Cannfly NeuroGuard 7,435 mg*, um extrato à base de cannabis (CBD 65%, CBG 10%, CBN 10%, CBC 5%, CBDA 5%, CBGA 4,8% e THC 0,2%) para tratamento de dor crônica (CID M54.2 e M54.5), fibromialgia (CID M79.7) e depressão grave (CID F32).

A Autora alegou que as condições médicas são refratárias a tratamentos convencionais. Narrou insucessos terapêuticos com diversas medicações (fluoxetina, desvenlafaxina, ciclobenzaprina, gabapentina, pregabalina, tramadol), uso prolongado de bomba de infusão de morfina intratecal (entre 2017 e 2022) e procedimentos cirúrgicos (infiltração lombar e rizotomia percutânea em 02/08/2023). A prescrição médica atestou o medicamento pleiteado como "recurso terapêutico imprescindível", na dosagem de 15 mg/kg/dia (60 frascos por ano), sendo o custo anual orçado em R$ 216.611,04 (ID 97759895 e 97759893).

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido (ID 101463777). Isso ocorreu sob o fundamento de que o medicamento era de uso domiciliar, cuja cobertura é excluída pelo artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. O indeferimento ainda foi fundamentado na Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), que se manifestou desfavoravelmente à demanda, devido à ausência de evidências científicas conclusivas sobre a eficácia para fibromialgia/dor crônica naquele momento.

A Autora interpôs Agravo de Instrumento, que teve a liminar negada (ID 101920602) e, posteriormente, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (Acórdão ID 105601751). Os fundamentos do Acórdão

convergiram com a decisão de primeira instância, destacando o parecer desfavorável do NATJUS e a exclusão de cobertura legal para fármacos de uso domiciliar, salvo as exceções previstas na lei.

Citada, a Ré Unimed João Pessoa apresentou Contestação (ID 107839287). Preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, defendeu a licitude da negativa de cobertura, baseada na exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI da Lei nº 9.656/98) e na ausência de inclusão do fármaco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Argumentou ainda, com apoio nas Notas Técnicas (NATJUS ID 107839288 e ID 107839289), a falta de evidências científicas robustas que justificassem a eficácia superior do Canabidiol para as condições da Autora, bem como a ausência de comprovação do esgotamento de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

A Autora apresentou Réplica à Contestação e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela (ID 107893309 e ID 111309613). Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a superação do Tema 990/STJ pela Autorização de Importação da ANVISA (RDC nº 660/2022), citando precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 111681175), mantendo-se o entendimento anterior e o chancelamento do Acórdão, por ausência de fato novo e reiteração dos mesmos fundamentos.

As partes foram, então, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. A Ré requereu o julgamento antecipado do mérito (ID 113801599). A Autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A Ré impugnou o benefício da justiça gratuita, sob a alegação de insuficiência de comprovação da hipossuficiência financeira da Autora.

O pedido de gratuidade foi deferido na decisão inicial com base nos documentos acostados, incluindo a declaração de isenção de Imposto de Renda (ID 97759889) e a declaração de hipossuficiência (ID 97759897).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural não foi afastada por prova robusta em sentido contrário apresentada pela Ré.

Diante disso, mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido, rejeitando a preliminar.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE

Constata-se, pela análise dos autos, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se traduz inequivocamente em **relação de consumo**, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**. Trata-se de vínculo jurídico atinente ao mercado de **prestação de serviços médico-hospitalares e suplementares de saúde**, no qual a autora figura como **consumidora e beneficiária** do plano contratado, e a ré, como **fornecedora de serviços**, na condição de operadora do plano de saúde.

O enquadramento jurídico decorre da **própria natureza do contrato de assistência à saúde**, que, embora disciplinado pela **Lei nº 9.656/98**, apresenta-se como típico contrato de **relação de consumo**, por inserir-se no contexto das atividades empresariais de fornecimento de serviços mediante remuneração.

Nesse panorama, o **artigo 2º** do **Código de Defesa do Consumidor** define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto o **artigo 3º, § 2º**, dispõe que serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária — categoria na qual se enquadram as **operadoras de planos de saúde**.

O entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do **Código de Defesa do Consumidor** aos contratos de planos de saúde encontra-se **plenamente pacificado** no âmbito do **Superior Tribunal de Justiça**, conforme sedimentado em seus enunciados sumulares.

Com efeito, a **Súmula nº 469/STJ** estabelece que:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

De igual modo, a **Súmula nº 608/STJ** dispõe:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Tais enunciados consolidam a compreensão de que as operadoras de saúde, enquanto fornecedoras de serviços no mercado de consumo, submetem-se aos ditames protetivos da legislação consumerista, ressalvada apenas a hipótese de planos de autogestão.

Dessa forma, ainda que a matéria referente aos planos de saúde seja regulada pela **Lei nº 9.656/1998**, as normas do **Código de Defesa do Consumidor** incidem **de maneira supletiva e complementar**, especialmente no que concerne à **interpretação das cláusulas contratuais**, à **observância da boa-fé objetiva** e à **tutela da parte hipossuficiente**.

DO MÉRITO

A controvérsia principal reside na obrigatoriedade ou não do plano de saúde de custear o medicamento *Cannfly NeuroGuard 7,435 mg*, um produto derivado de cannabis, prescrito para o tratamento de dor crônica, fibromialgia e depressão grave, sendo de uso domiciliar e sem registro de medicamento na ANVISA, embora autorizado para importação excepcional.

O ponto central desta análise refere-se à extensão da cobertura contratual, especificamente quanto a medicamentos de uso domiciliar não incluídos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante do presente caso, faz-se mister pontuar que o art. 10 da Lei nº 9.656/98 estabelece, em seu inciso VI, a exclusão expressa do "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", ressalvadas as exceções taxativas previstas no art. 12, I, *c*, e II, *g*, do mesmo diploma legal (tratamentos antineoplásicos orais e procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade de assistência hospitalar ou ambulatorial).

As exceções trazidas pelo artigo 12 são taxativas e não inclui a patologia da Autora (dor crônica/fibromialgia). Ainda, o medicamento pleiteado é um extrato de cannabis em óleo/solução oral (uso em frascos), sendo claramente de uso domiciliar.

Inserido nessa matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

> RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF). 4. A

> ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5**. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI edo § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998**. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Assim, conclui-se que as Operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar não listados no rol da ANS, ainda que prescritos para o tratamento de enfermidades específicas, como a fibromialgia, sobretudo quando não se trata de medicamento antineoplásico nem há indicação de necessidade de aplicação por profissional de saúde em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Nessa circunstância, tratando-se de fármaco de uso domiciliar não contemplado no rol da ANS, ainda que demonstrada, por documentação idônea, sua necessidade e adequação ao quadro clínico da autora, não se verifica hipótese que autorize a flexibilização da taxatividade do referido rol.

Por fim, faz-se mister pontuar a análise técnica realizada pelo NATJUS no curso do processo (que este Juízo acolheu no ID 101463777 e que foi confirmada pela Corte Superior no ID 105601751), que concluiu:

"Embora o canabidiol (CBD), um dos compostos encontrados na planta de cannabis, tenha atraído considerável atenção como uma potencial terapia para diversas condições de saúde, a evidência científica atual não demonstra de forma conclusiva a sua eficácia no tratamento da dor crônica e da fibromialgia."

"Vários estudos foram realizados para avaliar o impacto do CBD na dor crônica e na fibromialgia, mas os resultados têm sido variados e, muitas vezes, inconclusivos. A maioria dos estudos disponíveis é limitada por tamanhos amostrais pequenos, metodologias diversas e falta de controle metodológico rigoroso." (ID 107839289 e ID 107839288).

Assim, a divergência entre a prescrição do médico assistente e o parecer técnico do NATJUS, que questiona as evidências científicas para o tratamento da fibromialgia com Canabidiol, torna ausente a comprovação da eficácia clínica do fármaco para a patologia em questão, conforme exigido pelo artigo 13, inciso I, da Lei nº 9.656/98 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Ademais, o medicamento *Cannfly NeuroGuard* não possui registro na ANVISA como medicamento, sendo a Autorização de Importação (RDC nº 660/2022) uma dispensa sanitária para uso próprio que não equivale ao registro de medicamento para fins de obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde, especialmente em face do entendimento firmado neste Tribunal (Acórdão, ID 105601751).

Dessa forma, seguindo as conclusões do NATJUS, a jurisprudência do STJ e o entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba, que analisou a questão em sede de um juízo de cognição sumária e cujo fundamento se mantém inalterado na cognição exauriente, a operadora Ré agiu em exercício regular do seu direito e em conformidade com o arcabouço normativo que rege a saúde suplementar.

DO DANO MORAL

O pedido de indenização por danos morais baseou-se na recusa da Ré em fornecer o medicamento.

Considerando que a negativa de cobertura por parte da Ré estava amparada na exclusão legal e contratual do tratamento domiciliar (Lei nº 9.656/98, art. 10, VI), e nos pareceres técnicos que questionaram a eficácia conclusiva para a fibromialgia, afasta-se a ilicitude da conduta.

A recusa, neste caso, insere-se no campo da divergência interpretativa razoável acerca da extensão do contrato e da lei, não configurando ato ilícito doloso ou culposo apto a gerar dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para **JULGAR IMPROCEDENTE** o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, **observada a suspensão da exigibilidade nos termos do Artigo 98, § 3º, do CPC, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.**

Decorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Por outro lado, caso seja interposto recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoar (art.1010, NCPC), caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
18/11/2025 04:13:35
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 127474579

25111804133493800000110

IMPRIMIR GERAR PDF